

REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 11

AMPUTACIONES



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

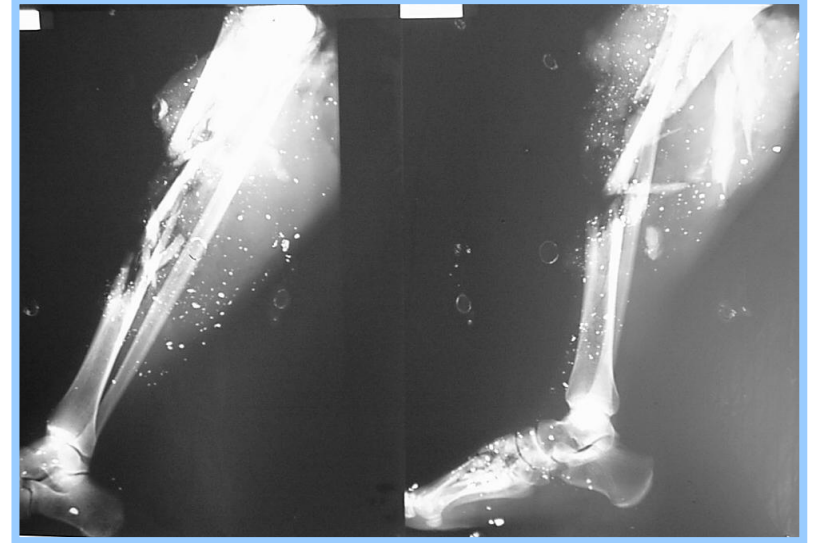
AMPUTACIÓN

Extirpación de un miembro (brazo o pierna) u otra parte del cuerpo mediante un proceso quirúrgico, consecuente de una lesión o enfermedad (diabetes, cáncer, etc.).

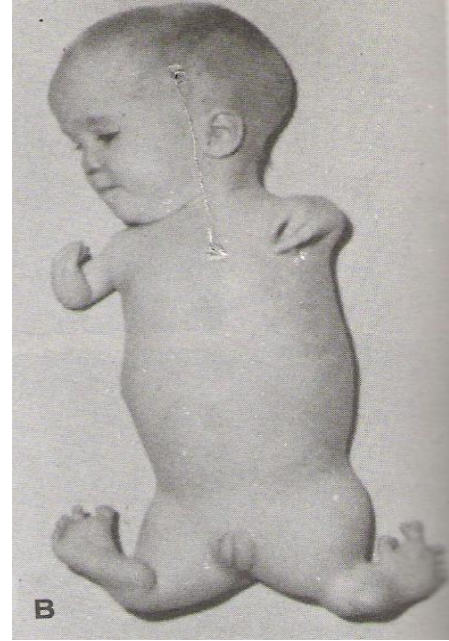
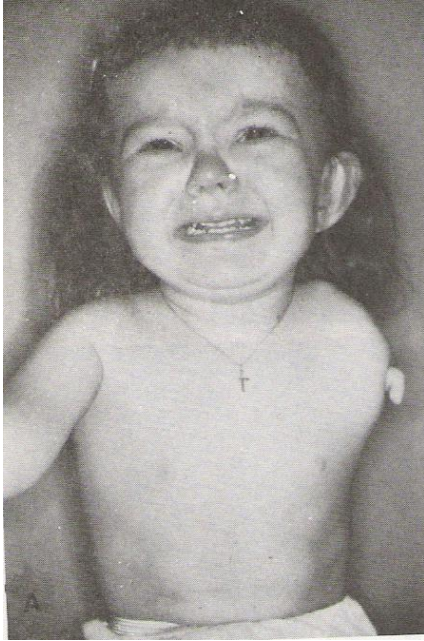


ETIOLOGÍA: TRAUMÁTICAS





CONGÉNITAS



TIPOS

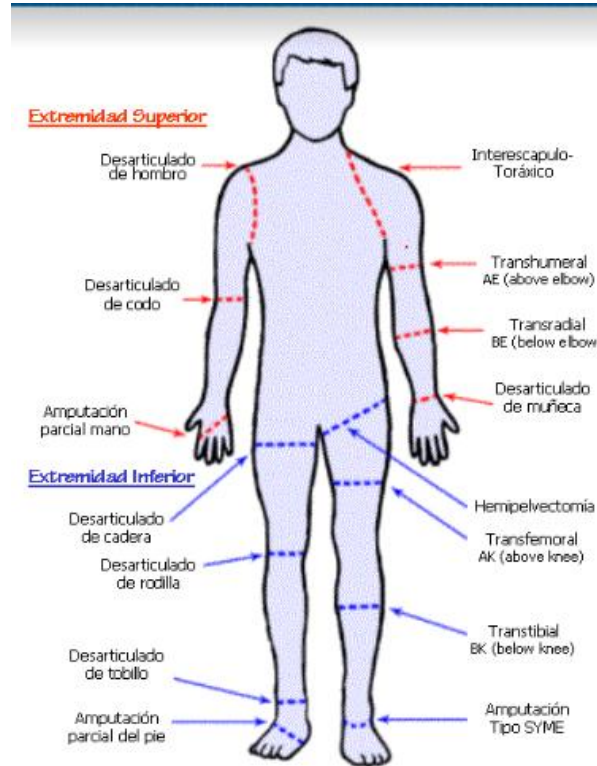
Cerrada: Realizada en pacientes previamente evaluados y sin peligro de infección.

Es ideal cerrar el muñón de la amputación bien cicatrizado y altamente funcional.

Abierta: Es la primera de, al menos, 2 operaciones requeridas para construir un muñón adecuado.

Es indicada en infecciones y heridas traumáticas con excesiva destrucción de tejido y contaminación con cuerpos extraños. La piel no es cerrada al final del muñón.

NIVELES DE AMPUTACIÓN



MUÑÓN

Según la OMS, el **muñón** se define como:

“La porción residual de un miembro tras una amputación, que queda luego de la extirpación quirúrgica o traumática de una extremidad”.

En el contexto clínico y de rehabilitación, el muñón no solo es un remanente anatómico, sino una estructura funcional clave que debe estar en condiciones óptimas (forma, cicatrización, sensibilidad y movilidad) para permitir la adaptación protésica y la recuperación funcional del paciente.



CARACTERÍSTICAS DEL MUÑÓN IDEAL

- Forma cónica o semicónica
- Revestimiento cutáneo bien nutrido
- Poseer suficiente irrigación sanguínea
- El nervio principal debe estar cortado por encima del nivel de la amputación
- Muñón no doloroso
- Cicatriz correcta y en el lugar adecuado

COMPLICACIONES

- Retardo en la cicatrización
- Infección
- Condiciones de la cicatriz
- Dolor residual
- Retracciones del muñón
- Prominencias óseas
- Sensibilidad

PRÓTESIS

Es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones, cumpliendo casi la misma función que un miembro natural, sea una pierna, un brazo, un pie, una mano, o bien uno o varios dedos. Pero existen varios otros tipos de prótesis, algunas de las cuales reemplazan funciones perdidas del cuerpo, mientras que otras cumplen funciones estéticas.



CARACTERÍSTICAS

- Cómoda
- Liviana
- Durable
- Cosmética
- Fácil mantenimiento
- Costo racional



EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL MUÑÓN DE AMPUTACIÓN

- Forma de muñón
- Estado de la cicatriz
- Espesor del tejido celular subcutánea
- Estado de la musculatura del muñón
- Edema distal
- Dolor
- Sensibilidad
- Grado de movimiento pasivo y activo de la articulación proximal

MIEMBRO CONTRALATERAL

- Postura
- Rango articular
- Fuerza muscular
- Complicaciones:
 - Dolor
 - Deformaciones

FASES DEL TRATAMIENTO

Etapa post operatoria inmediata y de cicatrización

- Duración: 3 -5 semanas

Etapa pre – protésica

- Abarca por lo menos 3 meses, hasta que se coloca la primera prótesis

Etapa protésica

- Adaptación de la prótesis hasta el día del alta

ETAPA DE CICATRIZACIÓN

Higiene

Prevención del dolor

Control del edema distal

Control postural general

OBJETIVOS

Disminución de la
hipersensibilidad

Tolerancia al contacto y
presiones

Movilización de la cicatriz

Vendaje

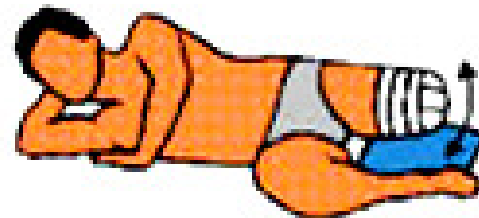
Capacidad aeróbica general

RUTINA DEL MUÑÓN

Mejorar el estado de la musculatura del muñón

Mejorar y mantener rangos articulares

Fortalecimiento de los músculos que estabilizan la articulación proximal



ETAPA PRE PROTÉSICA

Evitar posturas de flexión usando cama firme



No colocar almohadas debajo del muñón ni en región lumbar



No apoyar el muñón en las muletas.

Posición prona por lo menos 30 minutos al día.



Muñón alineado al cuerpo.



Estimular la posición bípeda inmediatamente algunos días después de la operación

Rutina de muñón

Entrenamiento
capacidad global

Acondicionamiento del
miembro contralateral

Objetivo

Preparar al amputado para
la adaptación de una
prótesis

FASE PRE PROTÉSICA



PACIENTE LISTO PARA LA PRÓTESIS

Sin dolor ni infección

No presencia de edema

Contractura muscular mínima

No adherencia de la cicatriz

No herida abierta

No debilidad muscular

La piel en buenas condiciones

Buen estado general

ETAPA PROTÉSICA

ENTRENAMIENTO CON PROTESIS PROVISIONAL

Es una etapa intermedia entre la pre - protésica y protésica y se inicia después de que concluye la etapa de cicatrización, siendo su propósito principal restablecer la propiocepción y del contacto con el suelo (MMII).

En el caso de los MMII:

- Aprender a descargar el peso corporal sobre la prótesis
- Controlar el equilibrio podal
- Controlar los apoyos y los movimientos del muñón
- Percepción de las nuevas sensaciones a través de los presorreceptores de la piel del muñón y las vías propioceptivas de la articulación de la cadera.
- Establecer un patrón de marcha
- La determinación de la capacidad funcional del paciente define la indicación de la prótesis permanente

FASE POST PROTÉSICA

